

## FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

## MINI · MINI ENTREVISTA NEUROPSIQUIÁTRICA INTERNACIONAL

*Mini International Neuropsychiatric Interview – Estándar diagnóstico estructurado breve para los trastornos del Eje I del DSM y CIE*

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Oficial</b>       | Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I. - Versiones 5.0.0 / 7.0.0)                                                                                        |
| <b>Autores Originales</b>   | David V. Sheehan, Yves Lecrubier, K. Sheehan, J. Janavs, E. Weiller et al. (1998)                                                                                         |
| <b>Validación Española</b>  | L. Ferrando, J. Bobes, J. Gibert, M. Soto, O. Soto-Loza (1998, 2000)                                                                                                      |
| <b>Tipo de Instrumento</b>  | Entrevista diagnóstica clínica estructurada administrada por profesional                                                                                                  |
| <b>Población Diana</b>      | Adolescentes y adultos (>= 16 años) en ensayos clínicos, consultas de salud mental y atención médica                                                                      |
| <b>Tiempo de Aplicación</b> | 15 a 25 minutos (frente a las 2-3 horas de la SCID o CIDI)                                                                                                                |
| <b>Formato de Respuesta</b> | Árbol de decisión dicotómico estructurado: Preguntas de cribado Sí / No con criterios nosológicos                                                                         |
| <b>Finalidad Clínica</b>    | Diagnóstico nosológico preciso y estandarizado de 16 categorías psiquiátricas del Eje I (DSM-IV / DSM-5 y CIE-10), despistaje de comorbilidad y cribado de riesgo suicida |

## 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Las entrevistas diagnósticas estructuradas tradicionales – como la Structured Clinical Interview for DSM (SCID) o el Composite International Diagnostic Interview (CIDI) – representan el patrón de máximo rigor científico pero resultan inviables en la práctica médica habitual y en ensayos clínicos masivos debido a su extensa duración (90 a 180 minutos) y su alta complejidad de administración.

La MINI fue creada conjuntamente por psiquiatras e investigadores de Estados Unidos y Francia (Sheehan y Lecrubier) con el propósito explícito de proporcionar un instrumento estructurado breve, fiable y altamente válido que explore en apenas 15-20 minutos los principales trastornos psiquiátricos del adulto. El diseño se basa en un sistema de “preguntas filtro” de entrada en cada módulo: si el paciente responde negativamente a los síntomas cardinales, el clínico salta de inmediato al siguiente módulo, optimizando drásticamente el tiempo de exploración.

## 3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

| Módulo Diagnóstico        | Sección                  | Trastornos Psiquiátricos Evaluados                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afectivos y Suicidio      | Módulos A, B, C, D       | A: Episodio Depresivo Mayor (actual/pasado); B: Riesgo Suicida (leve, moderado, alto); C: Episodio Maníaco / Hipomaniaco; D: Trastorno Distímico.                      |
| Ansiedad y Trauma         | Módulos E, F, G, H, I, O | E: Trastorno de Pánico; F: Agorafobia; G: Fobia Social; H: Trastorno Obsesivo-Compulsivo; I: Trastorno de Estrés Postraumático; O: Trastorno de Ansiedad Generalizada. |
| Sustancias y Psicosis     | Módulos J, K, L          | J: Abuso y Dependencia de Alcohol; K: Abuso y Dependencia de Sustancias (no alcohol); L: Trastornos Psicóticos (vida / actual).                                        |
| Alimentación y Adaptación | Módulos M, N, P          | M: Anorexia Nerviosa; N: Bulimia Nerviosa; P: Trastorno de la Personalidad Antisocial (en versión PLUS).                                                               |

## PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · MINI

## 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Validez Diagnóstica vs SCID</b>  | Excelente concordancia kappa con la SCID-P (valores kappa entre 0.70 y 0.88 en depresión, manía, pánico, agorafobia, fobia social y dependencia de alcohol; Sheehan et al., 1998; Ferrando et al., 1998). |
| <b>Sensibilidad y Especificidad</b> | Sensibilidad diagnóstica global > 85% y especificidad > 88% en comparación con entrevistas semiestructuradas extensas y juicio de panel de expertos.                                                      |
| <b>Fiabilidad Inter-Jueces</b>      | Coeficiente kappa inter-evaluador de 0.79 a 1.00 en todos los módulos diagnósticos tras formación básica estandarizada.                                                                                   |
| <b>Fiabilidad Test-Retest</b>       | Concordancia kappa test-retest de 0.75 a 0.88 tras intervalo de 1 a 3 días en pacientes ambulatorios psiquiátricos.                                                                                       |

## 5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Mecánica del Árbol de Decisión:** Cada módulo comienza con 1 o 2 preguntas filtro diagnósticas.
  - Si la respuesta es **NO**, el clínico codifica "NO" en el diagnóstico y salta inmediatamente al siguiente módulo.
  - Si la respuesta es **SÍ**, el clínico formula las preguntas subsidiarias explorando criterios de número de síntomas, duración temporal y deterioro funcional.
- Juicio Categorical Dicotómico:** Cada módulo concluye con una casilla diagnóstica: **NO CUMPLE** o **CUMPLE** el trastorno (actual o histórico).
- Módulo Especial de Suicidio (Módulo B):** Se asignan puntos específicos (de 1 a 10) a cada ítem de ideación, planeamiento y tentativa previa para obtener una estratificación:
  - 1 a 5 puntos = **Riesgo Leve**; 6 a 9 puntos = **Riesgo Moderado**;  $\geq 10$  puntos = **Riesgo Alto**.
- Hoja de Resumen Diagnóstico:** Al finalizar, el facultativo marca en la carátula todos los diagnósticos que cumplen criterios positivos.

## 6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

| Módulo Clínico         | Resultado MINI   | Criterio Nosológico       | Acción Terapéutica y Derivación                             |
|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cualquier Módulo Eje I | NO               | Criterio no alcanzado     | Descartar patología clínica en dicha esfera.                |
| Cualquier Módulo Eje I | SÍ               | Criterio nosológico pleno | Confirmación diagnóstica según DSM-IV/5 o CIE-10.           |
| Módulo B (Suicidio)    | 1 a 5 puntos     | Riesgo Suicida Leve       | Seguimiento ambulatorio; dinamizar apoyo familiar.          |
| Módulo B (Suicidio)    | 6 a 9 puntos     | Riesgo Moderado           | Valoración urgente por psiquiatría y plan de seguridad.     |
| Módulo B (Suicidio)    | $\geq 10$ puntos | Riesgo Suicida Alto       | Protocolo de emergencia vital e internamiento hospitalario. |

**VALOR DE LA EVALUACIÓN DE COMORBILIDAD:** La principal ventaja diagnóstica de la MINI radica en desvelar comorbilidades ocultas: más del 50% de los pacientes que consultan por ansiedad presentan un episodio depresivo mayor activo comórbido o un consumo de sustancias encubierto que condicionan la respuesta al tratamiento.

## APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · MINI

## 7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

**Paso 1: Administración Secuencial de la Entrevista:** Seguir textualmente las preguntas de cada módulo.

**Paso 2: Interpretación y Síntesis Multiaxial:**

- Si Módulo A positivo (Depresión) y Módulo C positivo (Manía/Hipomanía): reclasificar como Trastorno Bipolar I o II (contraindicación de monoterapia con antidepresivos).
- Si Módulo B (Suicidio)  $\geq 6$  puntos: priorizar contención de riesgo vital antes de cualquier otra intervención.
- Si Módulo J o K positivos (Sustancias): evaluar si los síntomas ansiosos o afectivos son primarios o inducidos por la intoxicación/abstinencia.

## 8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

**Identificación:** Varón de 37 años, administrativo, acude a consulta externa derivado por su médico de familia con volante interconsulta que refiere “Trastorno de Ansiedad Generalizada resistente a benzodiacepinas”.

**Exploración Diagnóstica con la MINI:**

- **Módulo A (Depresión Mayor):** POSITIVO (actual). Cumple 7 criterios incluyendo ánimo triste diario, anhedonia, pérdida de peso y culpa.
- **Módulo B (Riesgo Suicida):** 7 puntos (Riesgo Moderado). Pensamientos recurrentes de suicidio pasivo.
- **Módulo C (Manía):** NEGATIVO.
- **Módulo E y F (Pánico y Agorafobia):** NEGATIVO.
- **Módulo J (Alcohol):** POSITIVO (Dependencia actual). Consume 6 latas de cerveza al volver del trabajo para sedar la angustia.
- **Módulo O (TAG):** NEGATIVO (los síntomas ansiosos ocurren exclusivamente durante el episodio depresivo).

**Conclusión y Manejo Clínico:** La MINI reformuló por completo el diagnóstico de derivación, descartando TAG y estableciendo: 1) Trastorno Depresivo Mayor episodio único grave con riesgo suicida moderado; y 2) Trastorno por Dependencia del Alcohol secundario comórbido. Se suspendieron las benzodiacepinas a demanda, se inició pauta de sertralina (100 mg/día) y se derivó a psicoterapia cognitivo-conductual dual. A los 3 meses se constató remisión del cuadro afectivo y cese del consumo alcohólico.

## 9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

## ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Una puntuación  $\geq 10$  en el Módulo B obliga a una supervisión médica continuada y no permitir el abandono del centro sin acompañamiento.
- La presencia de psicosis activa en el Módulo L exige despistaje orgánico urgente (consumo de tóxicos o causa neurológica).

## CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

- **Criterio de Exclusión Médica:** Si el trastorno es atribuible a patología médica (ej. hipotiroidismo), no codificar como diagnóstico primario.
- **Uso en Ensayos Clínicos:** La MINI estandariza los criterios de inclusión/exclusión para garantizar la homogeneidad muestral.

## 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., ... & Dunbar, G. C. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): The development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. *Journal of Clinical Psychiatry*, 59(Suppl 20), 22–33.
- Ferrando, L., Bobes, J., Gibert, J., Soto, M., & Soto-Loza, O. (1998). MINI: Mini International Neuropsychiatric Interview (Versión en español 5.0.0). *Instituto Iberoamericano de Psicofarmacología*.
- Lecrubier, Y., Sheehan, D. V., Weiller, E., Amorim, P., Bonora, I., Sheehan, K. H., ... & Dunbar, G. C. (1997). The Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): A short diagnostic structured interview: Reliability and validity according to the CIDI. *European Psychiatry*, 12(5), 224–231.
- American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed., text rev.). APA.